

43-Développement des Côtes

Les côtes, elles sont liées à tout un processus développemental. Développement de l'ectoderme, du mésoderme, de l'anatomie vasculaire, de la cérébralisation, de la segmentation, du développement de l'intestin, des cavités, du cœur, du foie. Tout ça permettra finalement l'émergence globale du système costal. Et l'image, c'est ce qu'on appelle les théories de l'émergence. Il part d'un processus simple et finalement, chaque couche permet l'émergence d'une nouvelle couche. À partir d'un certain degré, il y a une complexité qui commence à se mettre et on commence à avancer. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus absorber. Et le système, il repasse par le chaos pour recommencer. Il faut permettre à un système, peut-être, de s'effondrer pour se reconstruire. Ce qui n'est pas toujours très agréable. Quand dans la vie, tu as reçu beaucoup de pression, quelle est ta réponse après ? C'est de faire une dépression. L'homme ne veut pas faire sa dépression. Il ne veut pas aller rechercher son conflit profond. Les côtes sont des densifications entre les vaisseaux thoraciques segmentés. Ça commence vers le 35ème jour. Tu as le corps vertébral et puis tu as l'arc ici, la côte en croissance qui commence vraiment à s'allonger et qui suit le mouvement développemental de l'embryon dans son mouvement de délimitation par ta cavité amniotique. J'ai cet axe central, j'ai les vaisseaux et j'ai toute cette phase de délimitation qui vient vers l'avant. Finalement, qui revient vers mon ombilisme. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tout ce processus de céphalisation, cardialisation, hépatisation, délimitation ait lieu pour avoir en fait. Et donc, de là, je vais avoir des vaisseaux qui viennent de la horte, qui poussent. Et entre les deux, je vais avoir ce qu'on appelle une densification de tissus mésodermiques entre les vaisseaux. Ça va s'allonger, ça va revenir vers la ligne médiane. Du 45ème jour, il y a comme une fracture entre guillemets. Qui devient une articulation chondrocostale. Et ça vient se

mettre vers ma ligne médiane. Au niveau de ma clavicule qui est ici. J'ai ici les deux boules manubrium qui se rejoignent vers la ligne médiane. Pour que mes barres sternales ici, donc des condensations mésenchymateuses se rejoignent également. Et viennent se centrer ici d'abord au niveau de l'angle de l'ouïe. Qui correspond au médiastin. Et petit à petit, pour former l'appendice hyphoïde qui apparaît. ... Après la naissance, au départ, vous avez encore presque deux niveaux comme ça. ... Parce que le sécum, il termine sa descente après la naissance. ... C'est aussi une image comme un utérus. Et ça se fait dans la même dynamique qui est ici, ça se fait dans la même dynamique qui est là. ... En même temps, j'ai cette cavité amniotique qui doit être construite, j'ai ce foie, ... et on voit apparaître ici, autour de ma vertèbre, avec ce qu'on appelle les myotomes, les dermatomes, ... on voit apparaître ce sclérotome, ici un mouvement, petit à petit, venir autour. Et on voit que ça se fait en même temps que tout un processus de délimitation de l'embryon. Je prends la côte comme ça, ou comme ceci, parce qu'elle est reliée à quelque chose qui est très intéressant. Vous avez parfois des gens qui viennent, qui ont reçu un coup. J'ai découvert ça chez les boxeurs, quand ils ont un coup, ils ont un moment donné comme une évrage intercostale. Si c'est pas cassé, c'est souvent en fait un problème avec la côte et avec un niveau sous-jacent qui est ici. Au même moment. Au même moment où j'ai cette côte qui se développe, j'ai cette plèvre pariétale qui suit, mais j'ai en même temps le repli interne de la plèvre viscérale, au niveau pulmonaire. Et c'est ce qu'on appelle le fascia endothoracique. Je travaille d'abord sur la motilité de la côte. Deuxième niveau, un peu plus profond, je descends plus bas ma conscience ici, pour aller dans la même direction par là, pour former la côte et la plèvre. Donc, je vais faire une plèvre pariétale, en profondeur ici, je rejoins la plèvre viscérale. Et le point de rencontre entre ma plèvre viscérale et ma plèvre pariétale va se faire au niveau du

hile pulmonaire. Libérer les côtes, c'est libérer le poumon. C'est une combinaison. C'est moi où je vais me projeter. Donc, je me mets ici. Ça, j'exagère, c'est le mouvement de développement de ma côte. Dans la profondeur, ici. J'ai à la fois maintenant un développement de ma côte, qui va suivre au même moment le développement de la plèvre pariétale. Et à l'intérieur, j'ai une rencontre entre les deux qui va faire la plèvre viscérale. Le point de rencontre va se retrouver sur le hile pulmonaire. Et donc, en travaillant sur le hile pulmonaire, j'ai tout l'équilibre entre le viscérale et le pariétal. émerger mes membres supérieurs. Ça n'empêche pas que je peux travailler chaque côte séparément, que je peux même travailler sur un plan vertébral direct, par des techniques directes ou indirectes, mais avoir tout ce grill costal libre, c'est libérer énormément d'échanges. C'est un mouvement comme ça. Deuxièmement, c'est un mouvement en profondeur pariétale, la rencontre pariétale viscérale, et le point de rencontre, île pulmonaire. Et de là, va émerger l'ébauche de mes membres supérieurs, que j'expliquerai en détail après, qui est une expansion du sac pleuro-pariétal. Vous connaissez l'importance de la quatrième côte à gauche. C'est un lieu très émotionnel. En fait, les côtes fonctionnent avec l'inspire et l'expire. Et ici, avec ces petits cartilages, il y a un phénomène, une très mauvaise nouvelle. Il y a un point émotionnel avec le rein et l'estomac, en fait. Mais en même temps, ça te verrouille ici. Et en fait, très souvent à gauche, la côte, elle ne redescend pas. Ça te laisse dans une histoire émotionnelle assez importante. Et ces gens ont des précordialgies, ils commencent à rentrer dans des phénomènes d'angoisse. Il faut aller simplement redégager ce niveau-là. Depuis le plan vertébral, tu vas la ramener dans son inspire. Tu la prends et puis tu la ramènes dans... Ré-expirer, quoi, tu vois. Et puis là, tu as tout le travail au niveau costal. Tu peux l'avoir dans le fascia ou dans les coudes globales, quoi. Mais c'est vraiment une zone importante à faire. Là, je la ramène. Là, je la

ramène ici. Et là, j'ai l'espace où je peux la ramener. Je la ramène là où elle veut bien aller. Je change ma position. Je la ramène ici. Et là, c'est une façon de la corriger facile. Et puis, je fais le travail au niveau de la côte. Et puis, je fais le travail au niveau endothoracique. Et je vais terminer au niveau de l'équilibre du hile pulmonaire.